

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

HDRS-17 · ESCALA DE HAMILTON PARA LA DEPRESIÓN (HAM-D)

Hamilton Depression Rating Scale — Patrón oro internacional de entrevista clínica heteroaplicada de 17 ítems

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial	Hamilton Depression Rating Scale - Versión de 17 ítems (HDRS-17 / HAM-D)
Autor Original	Max Hamilton (1960; revisión en 1967)
Validación Española	J. A. Ramos-Brieva y A. Cordero-Villafáfila (1986); Julio Bobes et al. (2003)
Tipo de Instrumento	Entrevista clínica estructurada heteroaplicada por facultativo de salud mental
Población Diana	Pacientes adultos y mayores con diagnóstico de Trastorno Depresivo Mayor
Tiempo de Aplicación	20 a 30 minutos (administrada por clínico entrenado)
Formato de Respuesta	Ítems con escala de 0 a 4 puntos (8 ítems) y de 0 a 2 puntos (9 ítems)
Finalidad Clínica	Cuantificación estandarizada de la severidad del episodio depresivo, monitorización de la respuesta a psicofármacos y determinación de remisión clínica completa

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

Publicada por Max Hamilton en 1960, la HDRS es históricamente la escala de evaluación psiquiátrica más citada y empleada en la investigación biomédica y en los ensayos clínicos de medicamentos antidepresivos en todo el mundo. Hamilton desarrolló la escala no para diagnosticar la depresión de novo, sino expresamente para medir de forma fidedigna y cuantitativa la **gravedad global** del cuadro en pacientes ya diagnosticados.

El marco conceptual otorga un peso sustancial a las manifestaciones melancólicas, psicomotoras y neurovegetativas de la depresión endógena clásica: los tres tipos de insomnio (conciliación, mantenimiento y despertar precoz), la pérdida de peso, la inhibición psíquica, la ansiedad somática y los síntomas gastrointestinales, combinados con las cogniciones nucleares depresivas (sentimientos de culpa patológica, ideación autolítica, desesperanza e hipocondría).

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Clúster Clínico	Nº Ítems	Ítems Constituyentes y Manifestaciones Evaluadas
Núcleo Depresivo	4 ítems	Ítem 1 Humor deprimido, Ítem 2 Sentimientos de culpa, Ítem 3 Suicidio e ideación autolítica, Ítem 7 Trabajo y actividades.
Patrón de Insomnio	3 ítems	Ítem 4 Insomnio precoz (conciliación), Ítem 5 Insomnio medio (despertares), Ítem 6 Insomnio tardío (despertar temprano).
Inhibición y Ansiedad	4 ítems	Ítem 8 Enlentecimiento psicomotor, Ítem 9 Agitación motora, Ítem 10 Ansiedad psíquica, Ítem 11 Ansiedad somática.
Síntomas Somáticos	4 ítems	Ítem 12 Gastrointestinales (hiporexia), Ítem 13 Somáticos generales (fatiga, pesadez), Ítem 14 Genitales (libido), Ítem 16 Pérdida de peso.
Insight e Hipocondría	2 ítems	Ítem 15 Hipocondría / preocupación corporal patológica, Ítem 17 Pérdida de conciencia de enfermedad (insight).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMACIÓN Y REGLAS DE CORRECCIÓN · HDRS-17

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATINOAMÉRICA

Consistencia Interna	Alfa de Cronbach = 0.72 a 0.84 en población española con depresión mayor (Ramos-Brieva & Cordero, 1986; Bobes et al., 2003).
Fiabilidad Inter-Jueces	Coefficiente de correlación intraclass (ICC) = 0.87 a 0.95 entre psiquiatras entrenados en la entrevista estructurada guía.
Validez Concurrente	Correlación sobresaliente con la escala de Montgomery-Asberg (MADRS, $r = 0.88$), con la escala CGI ($r = 0.82$) y con el BDI-II ($r = 0.74$).
Sensibilidad Terapéutica	Es la escala de referencia exigida históricamente por agencias reguladoras (FDA, EMA, AEMPS) para autorizar fármacos antidepresivos.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

1. Sistema Mixto de Puntuación:

- **8 ítems graduados de 0 a 4 puntos:** Ítems 1 (humor), 2 (culpa), 3 (suicidio), 7 (trabajo/actividades), 8 (enlentecimiento), 9 (agitación), 10 (ansiedad psíquica) y 11 (ansiedad somática).
- **9 ítems graduados de 0 a 2 puntos:** Ítems 4, 5, 6 (insomnios), 12, 13 (somáticos), 14 (genital), 15 (hipocondría), 16 (peso) y 17 (insight).

2. Puntuación Total: Suma directa de los 17 reactivos (la versión canónica estándar aprobada es estrictamente de 17 ítems).

3. Rango de Puntuación: De 0 a 52 puntos totales.

4. Criterio Estándar de Respuesta: Reducción $\geq 50\%$ en la puntuación respecto a la línea de base.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación HDRS	Estratificación	Gravedad Clínica	Directriz Asistencial y Psiquiátrica
0 a 7 puntos	Eutimia / Remisión	Asintomático	Remisión clínica completa. Mantener profilaxis.
8 a 13 puntos	Depresión Leve	Grado Menor	Psicoterapia de apoyo; considerar psicofármacos según caso.
14 a 18 puntos	Depresión Moderada	Cuadro Significativo	Antidepresivos en monoterapia (ISRS/IRSN) + psicoterapia.
19 a 22 puntos	Depresión Grave	Cuadro Severo	Tratamiento farmacológico intensivo; vigilancia estrecha.
≥ 23 puntos	Depresión Muy Grave	Incapacitante / Vital	Ingreso psiquiátrico urgente o considerar TEC si refractaria.

CRITERIO OFICIAL DE REMISIÓN COMPLETA (HDRS-17 ≤ 7): El objetivo del tratamiento antidepresivo es alcanzar una puntuación total en la HDRS de 7 o menos puntos. Los pacientes que sólo logran una respuesta parcial (HDRS entre 8 y 12) mantienen una tasa de recaídas a 1 año tres veces superior a la de los pacientes en remisión estricta.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y DIRECTRICES · HDRS-17

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA E INTERVENCIÓN

Paso 1: Entrevista Heteroaplicada Basal: Administrar por el psiquiatra o psicólogo clínico antes de instaurar tratamiento.

Paso 2: Monitorización a las 4, 8 y 12 semanas:

- **Si HDRS Total ≤ 7 :** Remisión alcanzada. Mantener dosis farmacológica plena durante 6 a 12 meses (primer episodio) para evitar recaídas.
- **Si reducción $< 50\%$ tras 4-6 semanas a dosis óptimas:** Resistencia inicial.
 1. Optimizar dosis a límites máximos autorizados.
 2. Si persiste la refractariedad, rotar de familia farmacológica (de ISRS a IRSN o multimodal como vortioxetina).
 3. Considerar estrategias de potenciación con litio, aripiprazol o quetiapina.
- **Si HDRS ≥ 23 con inhibición catatónica o negativa a la ingesta:** Indicar TEC (Terapia Electroconvulsiva).

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO (VIGNETTE)

Identificación: Varón de 56 años, directivo de banca prejubilado, remitido con urgencia a consulta de psiquiatría por anhedonia total, pérdida de 7 kg en 2 meses y vivencia de ruina económica injustificada.

Evaluación Psicométrica Inicial en HDRS-17: Total = 28 / 52 puntos (Depresión Muy Grave).

- **Núcleo Afectivo:** Humor profundamente triste y desesperanzado (ítem 1 = 4); convicción delirante de culpa por arruinar a su familia (ítem 2 = 4); ideación suicida pasiva continua deseando no despertar (ítem 3 = 2); abandono de toda actividad (ítem 7 = 4).
- **Patrón Vegetativo:** Despertar precoz a las 4:00 AM con angustia extrema (ítem 6 = 2); hiporexia severa con pérdida ponderal objetiva (ítems 12 = 2, 16 = 2); enlentecimiento psicomotor manifiesto al hablar (ítem 8 = 3).

Tratamiento y Evolución: Se diagnosticó Depresión Mayor Grave con síntomas melancólicos y psicóticos congruentes. Se pautó venlafaxina (titulada a 225 mg/día) potenciada con olanzapina (5 mg/noche). A las 8 semanas de tratamiento, la puntuación en la HDRS descendió a 5 puntos, recuperando el apetito y remitiendo por completo las ideas delirantes de culpa y la ideación autolítica.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ALERTA CRÍTICA DE SUICIDIO

- Una puntuación en el ítem 3 ≥ 2 (ideas autolíticas explícitas) obliga a evaluar de inmediato acceso a métodos letales y activar protocolo antisuicidio.
- En las primeras semanas de tratamiento farmacológico, la mejoría motora antes que la afectiva puede facilitar el paso al acto suicida.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- **Depresión Bipolar:** Descartar antecedentes de hipomanía previa antes de pautar antidepresivos solos para evitar virajes.
- **Demencia Incipiente:** El enlentecimiento del ítem 8 puede confundirse con deterioro cognitivo orgánico subcortical.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

- Hamilton, M. (1960). A rating scale for depression. *Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry*, 23(1), 56–62.
- Ramos-Brieva, J. A., & Cordero-Villafañila, A. (1986). Validación de la versión castellana de la Escala de Hamilton para la Depresión. *Actas Luso-Españolas de Neurología, Psiquiatría y Ciencias Afines*, 14(4), 324–338.
- Bobes, J., Bulbena, A., Luque, A., Dal-Ré, R., Ballesteros, J., & Ibarra, N. (2003). Evaluación de la comorbilidad ansioso-depresiva en atención primaria. *Actas Españolas de Psiquiatría*, 31(2), 57–63.
- Zimmerman, M., Posternak, M. A., & Chelminski, I. (2004). Defining remission on the Hamilton Depression Rating Scale: A comparison of standard cuts. *Journal of Clinical Psychiatry*, 65(9), 1184–1188.